

Manejo do Sangramento Digestivo Alto

Lucas de Oliveira Araújo

Médico Intensivista Diarista da Unidade de Terapia Intensiva de
Gastroenterologia do HCFMUSP



Definições

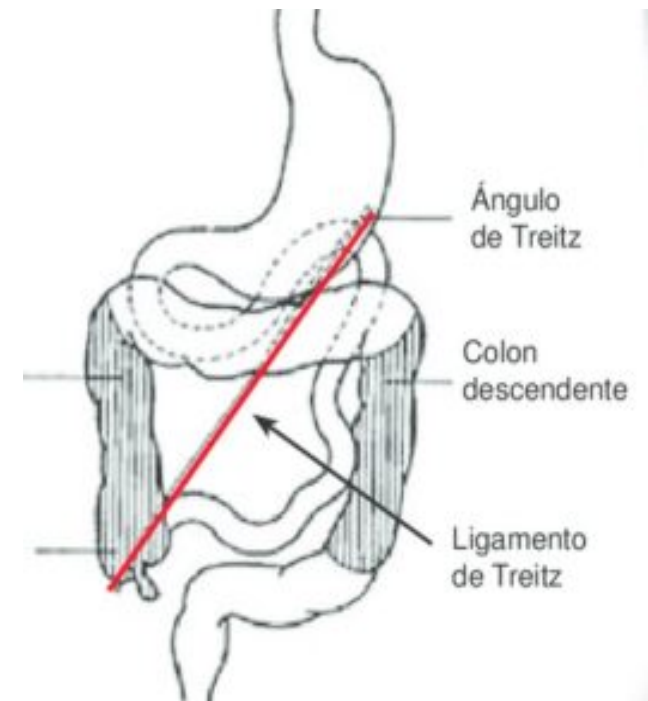
Sangramento Digestivo Alto

- Acometimento de qualquer ponto acima do ângulo de Treitz
- Pode se exteriorizar via alta e baixa

Sangramento Digestivo Médio

Sangramento Digestivo Baixo

- Acometimento de qualquer ponto abaixo do ângulo de Treitz
- Exterioriza-se apenas por via anal



Formas de Apresentação

Hematêmese: sangramento através dos vômitos

Melena: sangue oxidado com escurecimento e fetidez

Hematoquezia: sangramento normalmente de pequena monta associado ao ato evacuatório

Enterorragia: hemorragia volumosa sem associação com o ato evacuatório

Sangramento oculto: detectado através de pesquisa laboratorial ou suspeitada a partir de anemia persistente

Fatores confundidores: bismuto, carvão, alcaçuz e ferro – fezes enegrecidas sem HDA



Formas de Apresentação - HDA

- Varicosa: ocorre a partir da ruptura de varizes relacionadas com Hipertensão Portal
 - Mecanismo pode ocorrer também em outros pontos do TGI - HDB
- Não-varicosa: erosão ou ulceração vascular a partir de lesão aguda na mucosa gastrointestinal



Epidemiologia

HDA

- Mortalidade de 6-14%
- Maior em indivíduos > 60 anos e/ou com múltiplas comorbidades

HDB

- Mortalidade de 2-4%
- Doença diverticular é a causa mais comum, excedendo 20% do total de casos admitidos no hospital
- Doenças anorretais são a segunda causa, com sangramento hemorroidal de prevalência variável (12-21%)



Dados da História - HDA

Episódios anteriores de sangramento anterior > 60% recorrem pela mesma lesão

Doença hepática preexistente ou abuso de álcool > varizes ou gastropatia hipertensiva

Doença renal, estenose aórtica > Angiodisplasia

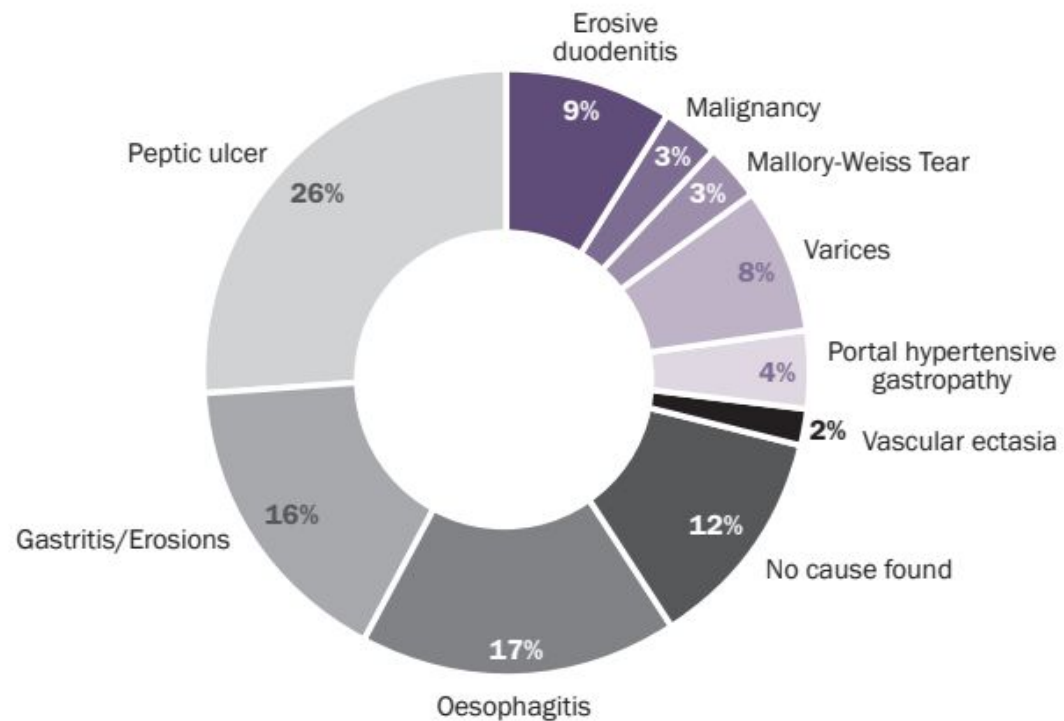
AINES, antitrombóticos, tabagismo, H. pylori > úlcera péptica

Tabagismo, álcool, H. pylori > malignidade

Anastomose gastroentérica > úlceras marginais



Etiologias Gerais HDA



J R Coll Physicians Edinb 2017; 47: 218–30

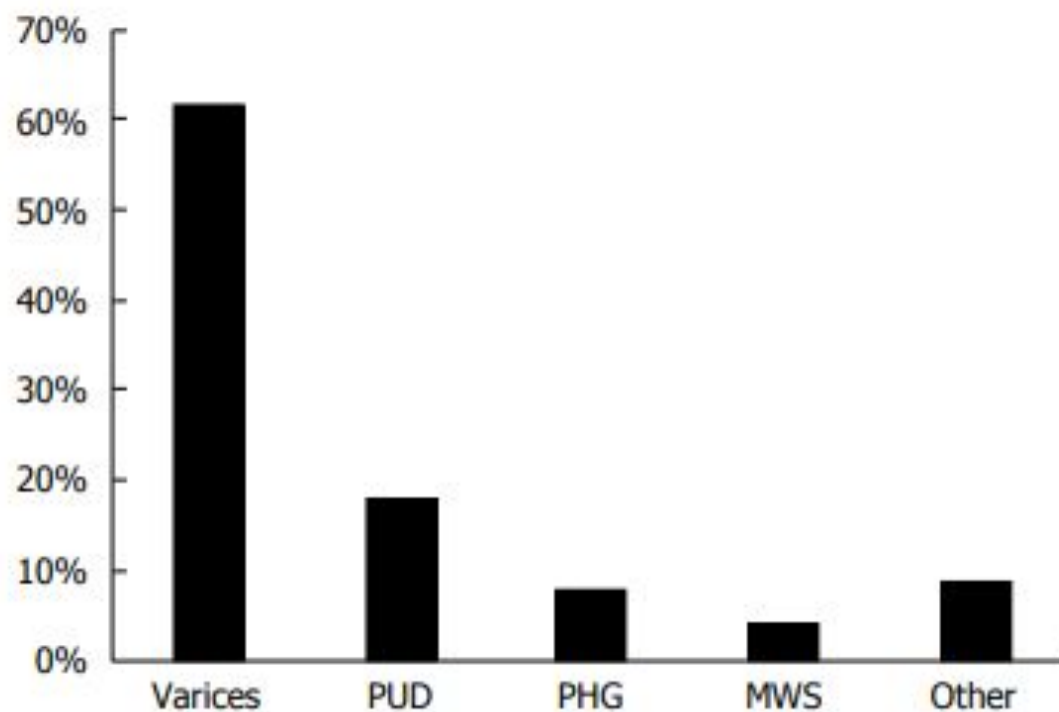


Etiologia	Prevalência Aproximada
Doença ulcerosa péptica (PUD)	40%–63%
Varizes esofágicas/gástricas	4%–16%
Gastrite/duodenite	18%–22%
Esofagite	8%–20%
Angiodisplasia	4%–6%
Laceração de Mallory-Weiss	5.0%–7.4%
Ectasias vasculares do antro gástrico	2.3%–4.0%
Neoplasia maligna	2.6%–4%
Lesão de Dieulafoy	1.5%–2.3%
Lesão de Cameron	<1%
Hemobilia	<1%
Hemosuccus pancreaticus	<1%
Fístula aortoentérica	<1%
Nenhuma lesão identificada	10%–15%

Gastroenterology Report, Volume 11, 2023, goad011



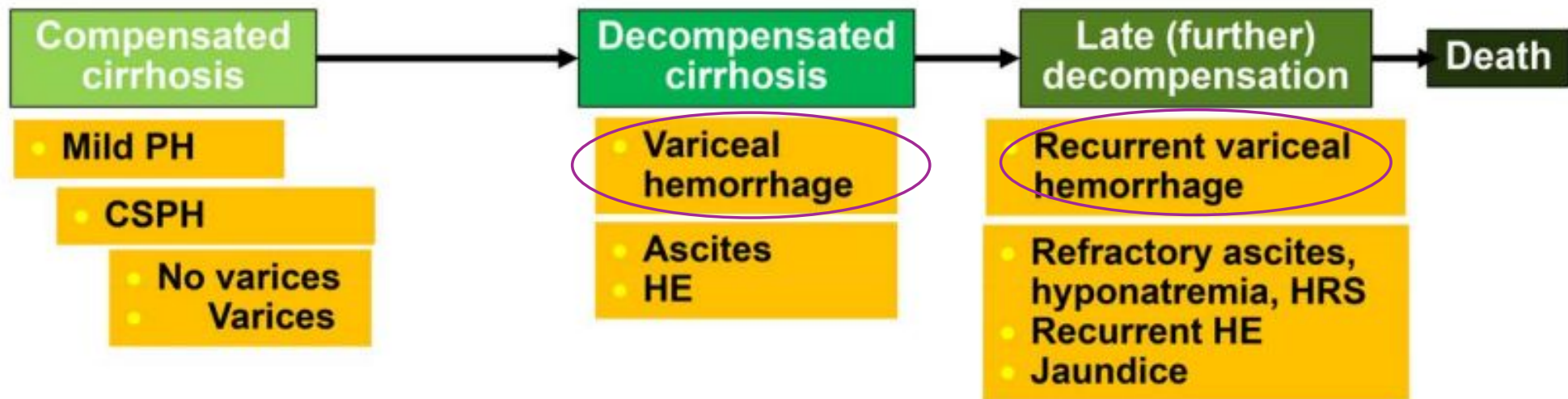
Etiologia de HDA em Cirróticos



Nojkov B et al. World J gastroenterol 2016; 22(1):446-466



Modelo de Evolução na Doença Hepática



GARCIA-TSAO ET AL. HEPATOLOGY, Vol. 65, No. 1, 2017



Modelo de Evolução na Doença Hepática

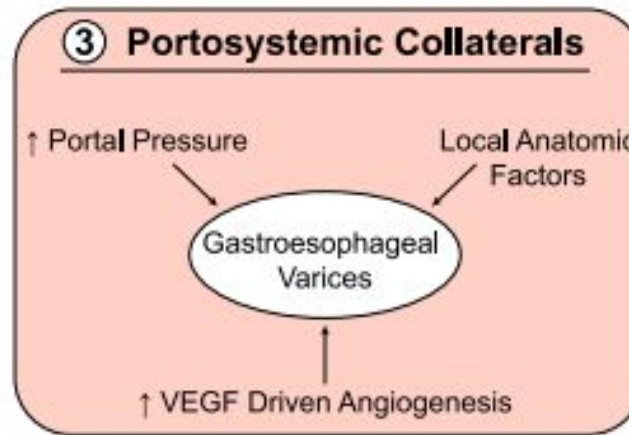
Stages of chronic liver disease	No cirrhosis	Compensated cirrhosis		Decompensated cirrhosis	
		Lower risk of decompensation	Higher risk of decompensation	First decompensation	Further decompensation
Clinical features (ascites, VH or HE)	None	None	None	One event	>1 event or complication of event*
Histological diagnosis	F0-F2	F3/F4 (thin septa)	F4 (thick septa)	Clinical	Clinical
Hemodynamic features (HVPG mmHg)	3-5	5-10	>10 (CSPH)	>20 worse outcomes in VH	>20 worse outcomes in VH
Endoscopic features	None	No varices	± Varices	± Varices	± Varices

Risk of death

Hepatology.
2024;79:1180–1211



Estimando Risco de Sangramento



Variceal Bleeding

$$\text{Variceal bleeding risk} = \frac{\text{Portal pressure X Varix diameter}}{\text{Wall thickness (red signs)}}$$

Hepatology. 2024;79:1180–1211



Estimando Risco de Sangramento



F1: varizes de formato reto (não desaparecem com a insuflação)

F2: varizes tortuosas levemente aumentadas ocupando menos de um terço do lúmen esofágico

F3: varizes de grandes lados ocupando mais de um terço do lúmen esofágico



Manejo Inicial

Proteção de via aérea: hematêmese, EH, instabilidade hemodinâmica

Hipotensão permissiva: redução de tensão endotelial

Estimar a perda volêmica do paciente

- Letargia, confusão, extremidades frias quando maior que 40%

Intervenção farmacológica: antes de descobrir a origem do sangramento (IBP + octreotide)

Eritromicina: pode ser considerada antes da endoscopia de emergência (250 mg iv, 30–120 min antes)

Profilaxia antimicrobiana (cefalosporina de terceira geração ou quinolonas)



Avaliação do regime da EDA

Am J Gastroenterol 2021;116:899–917.

Table 2. Glasgow-Blatchford score

Risk factors at admission	Factor score
Blood urea nitrogen (mg/dL)	
18.2 to <22.4	2
22.4 to <28.0	3
28.0 to <70.0	4
≥70.0	6
Hemoglobin (g/dL)	
12.0 to <13.0 (men); 10.0 to <12.0 (women)	1
10.0 to <12.0 (men)	3
<10.0	6
Systolic blood pressure (mm Hg)	
100–109	1
90–99	2
<90	3
Heart rate (beats per minute)	
≥100	1
Melena	1
Syncope	2
Hepatic disease ^a	2
Cardiac failure ^a	2

Estratificação de Risco HDA Não Varicosa

Escore de Rockall

VARIÁVEIS	PONTUAÇÃO			
	0	1	2	3
Idade	< 60	60 - 79	> ou = 80	–
Estudo volêmico	Sem choque	P > 100 bpm / PAS > 100 mmHg	P > 100 bpm / PAS < 100 mmHg	–
Comorbidades	Nenhuma	Nenhuma	ICC, ICO, outras comorbidades importantes	IR ou IH, CARCI
Diagnóstico	Mallory-Weiss, sem lesões ou EHR	Todos os outros diagnósticos	Câncer gastrointestinal (GI)	–
Estigma endoscópico	Ausente ou coágulo plano	–	Sangue no trato GI alto, coágulo aderido, vaso visível ou sangramento ativo	–

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

JANUARY 3, 2013

VOL. 368 NO. 1

Transfusion Strategies for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding

Comparação randomizada de limiares de 7 g/dL versus 9 g/dL em 899 pacientes

- Mortalidade em 45 dias como desfecho primário.
- Exclusão de Pacientes com sangramento maciço e com vasculopatia periférica sintomática, acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório nos últimos 90 dias.

N Engl J Med 2013;368:11-21

SUPERIORIDADE DO BRAÇO RESTRITIVO

- menos transfusão (49% vs 86%, $P < 0,001$)
- menor mortalidade (5% vs 9%, $P < 0,02$; [HR] 0,55, IC 95% 0,33–0,92),
- menos sangramento adicional (10% vs 16%, $P < 0,01$),
- menos reações transfusionais (3% vs 9%, $P < 0,001$)
- menos complicações cardíacas (11% vs 16%, $P < 0,04$)

INTENSIVE

Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal Transfusão de sangue: Systematic review and meta-analysis of

Sally Hopewell, Susan J Brunskill,

	Country	Design	Intervention haemoglobin threshold	Follow-up	Outcomes reported
Blair et al, 1986 ¹³	UK	Single centre, parallel group	Restrictive: 80 g/L; liberal: no threshold (all received two units of red blood cells)	Not stated	Laboratory measures of coagulation (primary), mortality, rebleeding, red blood cell transfusions
Lee et al, 2014 ¹⁴	South Korea	Single centre, parallel group	Restrictive: 80 g/L; liberal: 100 g/L	Not stated	Rebleeding*
Jairath et al, 2015 ⁶	UK	Multicentre, cluster randomised	Restrictive: 80 g/L; liberal: 100 g/L	28 days	Feasibility (primary), mortality, rebleeding, acute myocardial infarction, stroke, transfusion reactions, acute kidney injury, bacterial infection, red blood cell transfusions, duration of hospital admission
Villanueva et al, 2013 ⁷	Spain	Single centre, parallel group	Restrictive: 70 g/L; liberal: 90 g/L	45 days	Mortality (primary), rebleeding, acute myocardial infarction, stroke, transfusion reactions, acute kidney injury, bacterial infection, red blood cell transfusions, duration of hospital admission
Villarejo et al, 1999 ¹⁵	Argentina	Single centre, parallel group	Restrictive: haematocrit 21%; liberal: haematocrit 28%	Not stated	Mortality, rebleeding, acute myocardial infarction, stroke, duration of hospital admission*

*No primary outcome specified for Lee et al¹⁴ or Villarejo et al.¹⁵

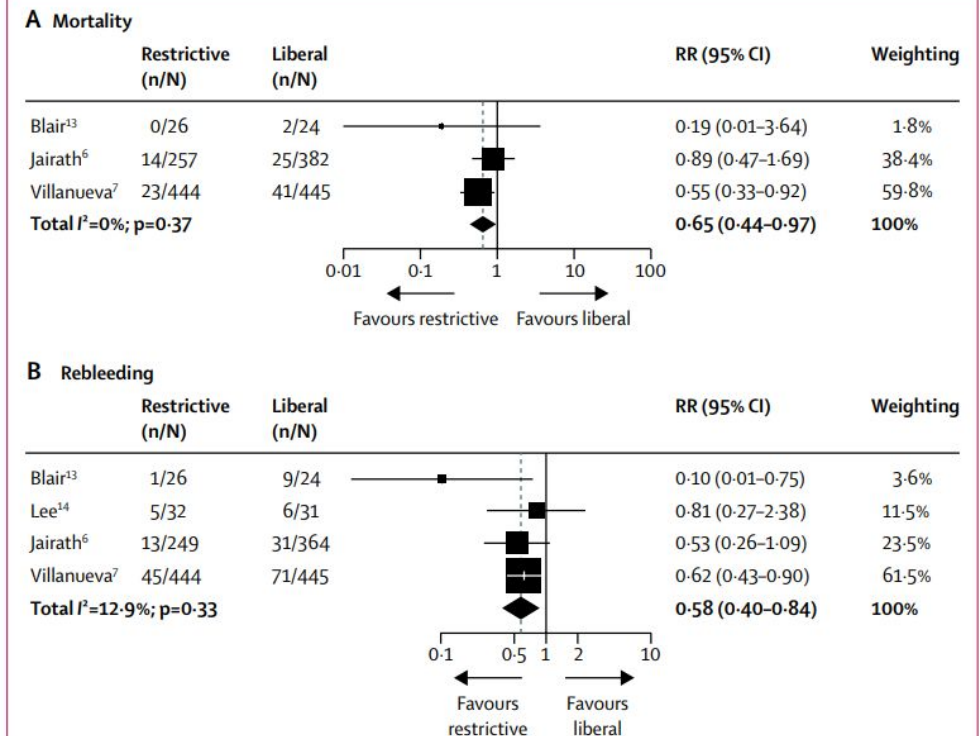
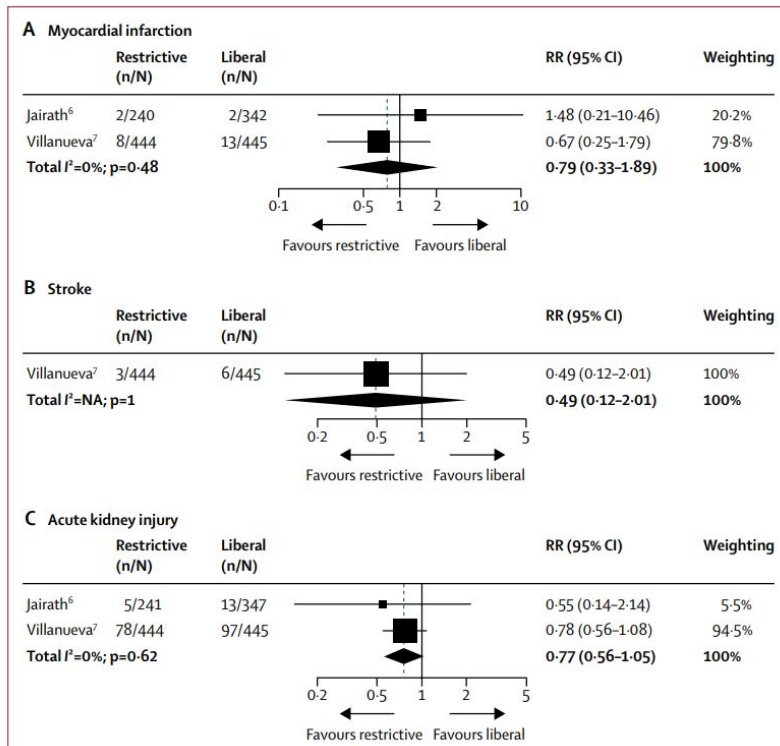
Table 1: Characteristics of included studies

. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017 May;2(5):354-360.



Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials

Ayodele Odutayo*, Michael J R Desborough*, Marialena Trivella, Adrian J Stanley, Carolyn Dorée, Gary S Collins, Sally Hopewell, Susan J Brunskill, Brennan C Kahan, Richard F A Logan, Alan N Barkun, Michael F Murphy, Vipul Jairath



. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017 May;2(5):354-360.

Manejo de Coagulopatias

Coagulopathy	Threshold	Management
Platelets	$<50 \times 10^9/L$	Platelet transfusion
INR	>1.5	FFP PCC (if on warfarin)
aPTTr	>1.5	FFP
Fibrinogen	$<1.5g/L$	FFP Cryoprecipitate (if low despite FFP)

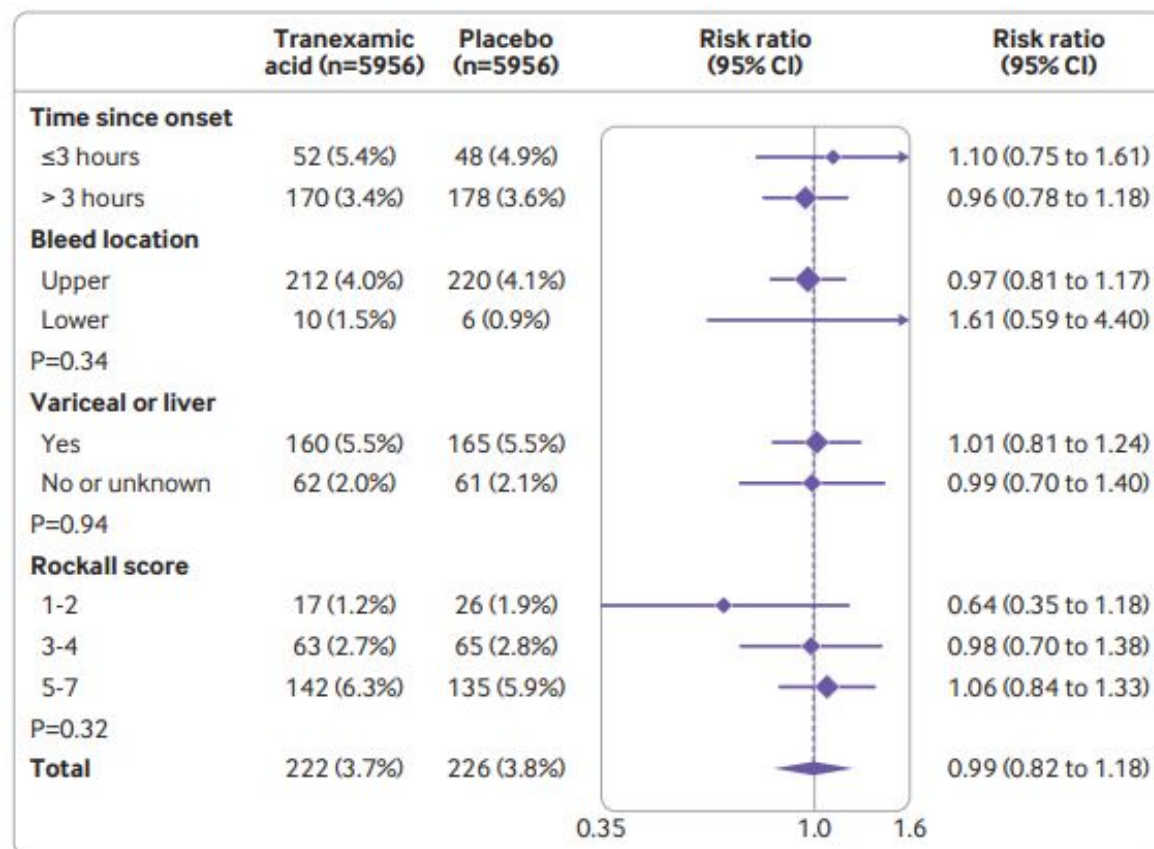
INR, International Normalised Ratio; aPTTr, activated partial thromboplastin time ratio; PCC, prothrombin complex concentrate; FFP, fresh frozen plasma.

J R Coll Physicians Edinb 2017; 47: 218–30



Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding (HALT-IT): an international randomised, double-blind, placebo-controlled trial

The HALT-IT Trial Collaborators*



Lancet 2020; 395: 1927–36



Prophylactic Antibiotics for Upper Gastrointestinal Bleeding in Patients With Cirrhosis

A Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis

Connor Probst, MD; Dean Noutsios, MD; Laurie-Rose Dubé, MD; Rachel Baden, MD; Kusha Davar, MD; Sarah Frelitz, MD;

Treatment regimen and participants, No.	
Long-duration group	Short-duration group
60 Patients Norfloxacin, 400 mg, orally twice daily for 7 d	59 Patients No prophylaxis
47 Patients Imipenem-clastatin, 500 mg IV once plus a second dose 6 h later if sclerotherapy was performed	50 Patients Dextrose-saline
46 Patients Ofloxacin, 400 mg IV, orally once daily for 10 d plus amoxicillin-clavulanate, 1 g, IV before endoscopy procedure	45 Patients No prophylaxis
19 Patients Cefotaxime, 1 g, IV once before endoscopy procedure	20 Patients No prophylaxis
30 Patients Amoxicillin-clavulanate, 1 g, orally or IV 3 times daily, and ciprofloxacin, 200 mg, orally or IV twice daily until 3 d after hemorrhage cessation	34 Patients No prophylaxis
60 Patients Ciprofloxacin, 500 mg, orally twice daily for 7 d	60 Patients Placebo

Treatment regimen and participants, No.	
Long-duration group	Short-duration group
20 Patients Ciprofloxacin, 200 mg, IV every 12 h for 3 d	20 Patients No prophylaxis
47 Patients Cefazolin, 1 g, IV every 8 h for 3 d, then cephalexin, 500 mg, orally every 6 h for 4 d	50 Patients No prophylaxis
59 Patients Ofloxacin, 200 mg, IV every 12 h for 2 d, then 200 mg orally every 12 h for 5 d	61 Patients No prophylaxis
62 Patients Cefotaxime, 2 g, IV every 8 h for 7 d	58 Patients No prophylaxis
30 Patients Ofloxacin, 200 mg, IV for every 12 h for 2 d, then 200 mg orally every 12 h for 5 d	26 Patients No prophylaxis
39 Patients Ceftriaxone, 500 mg, IV every 12 h for 7 d	40 Patients Ceftriaxone, 500 mg, IV every 12 h for 3 d
90 Patients Ceftriaxone, 1 g, IV every 24 h for 3 d	90 Patients No prophylaxis
48 Patients Ceftriaxone, 1 g, IV every 24 h for 5 d	52 Patients Ceftriaxone, 1 g, IV every 24 h for 2 d



Prophylactic Antibiotics for Upper Gastrointestinal Bleeding in Patients With Cirrhosis A Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis

Connor Probst, MD; Dean Noutsios, MD; Laurie-Rose Dubé, MD; Rachel Baden, MD; Kusha Davar, MD; Sarah Frelind, MD;

Figure 1. All-Cause Mortality Among Patients With Cirrhosis and Upper Gastrointestinal Bleeding

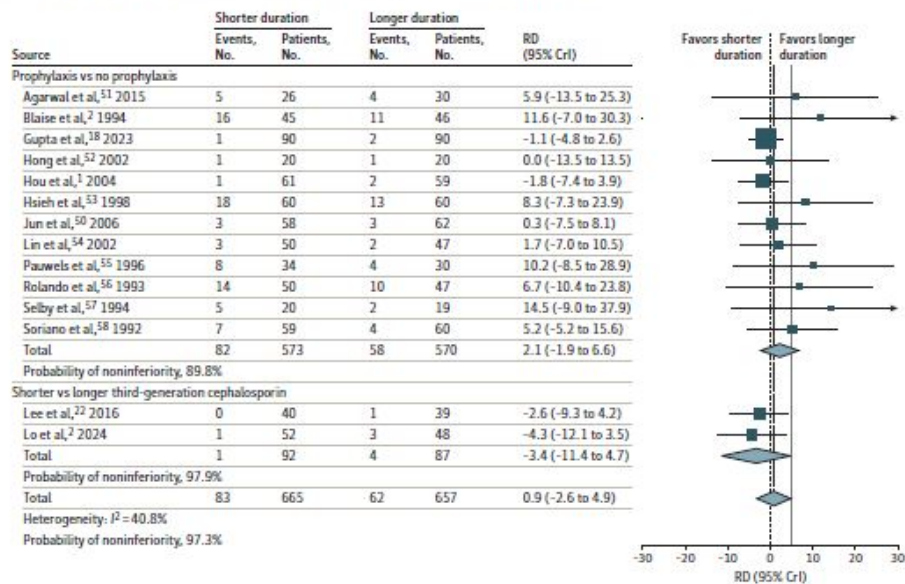
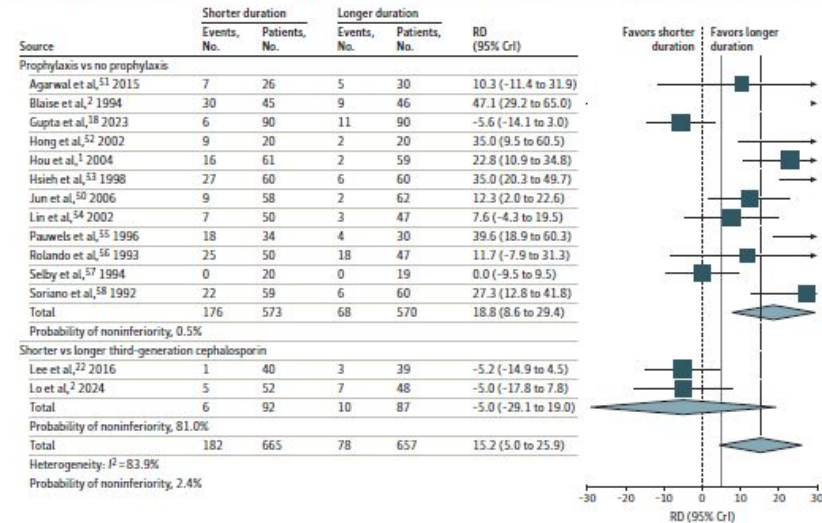


Figure 4. Bacterial Infections Among Patients With Cirrhosis and Upper Gastrointestinal Bleeding Treated With Prophylactic Antibiotics



Análogos da Somatostatina – HDA Varicosa

PARÂMETRO	TERLIPRESSINA N = 261	SOMATOSTATINA N = 259	OCTREOTIDE N = 260
Bolus antes da endoscopia	2 mg EV em bolus	250 mcg em bolus	50 mcg em bolus
Dosagem em cinco dias	1 mg a cada 6h por 5 dias	250 mcg/h por 5 dias	25 mcg/h por 5 dias
Sangramento ativo em endoscopia inicial	43.7%	44.4%	43.5%
Sucesso terapêutico no 5º dia	86.2%	83.4%	83.8%
Ressangramento	3.4%	4.8%	4.4%
Mortalidade	8%	8.9%	8.8%

Macedonian Journal of Medical Sciences. 2022 Feb 24



CME

ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding

PPI therapy.

4. We could not reach a recommendation for or against pre-endoscopic PPI therapy for patients with UGIB.

Am J Gastroenterol 2021;116:899–917

N Engl J Med 2007;356:1631–40.

Table 5. Double-blind placebo-controlled randomized trial of omeprazole bolus followed by continuous infusion started before endoscopy in patients presenting to emergency department with hematemesis or melena (32)

Outcome	Omeprazole (N = 314)	Placebo (N = 317)
Hours of infusion before endoscopy, mean $\pm$ SD	14.7 $\pm$ 6.3	15.2 $\pm$ 6.2
Further bleeding (30 d), n (%)	11 (3.5)	8 (2.5)
Death (30 d), n (%)	8 (2.5)	7 (2.2)
Hospital days, mean $\pm$ SD	4.5 $\pm$ 5.3	4.9 $\pm$ 5.1
Units of blood transfused, mean $\pm$ SD	1.54 $\pm$ 2.41	1.88 $\pm$ 3.44
Endoscopic therapy, n (%)	60 (19.1) ^a	90 (28.4)

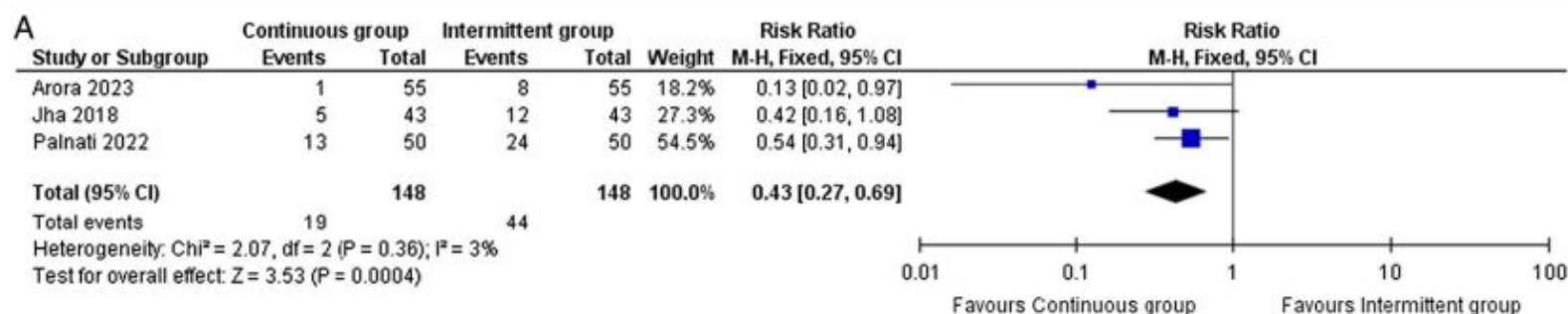
^a $P = 0.007$ vs placebo.



OPEN

Continuous vs. intermittent terlipressin infusion for portal hypertension: a systematic review and meta-analysis

Mona Hassan, MD^a, Nooraldin Merza, MD^b, Yusuf Nawras, BS^d, Eshak I. Bahbah, MD^{h,*}, Alsadiq Al-Hillan, MD^g, Zohaib Ahmed, MD^a, Saad El D. M. ElSheref, MD^h, Dushyant S. Dahiya, MD^f, Sophia Dar, MD^g, Mohammed Al Azzawi, MD^c, Abdallah Kobeissy, MD^a



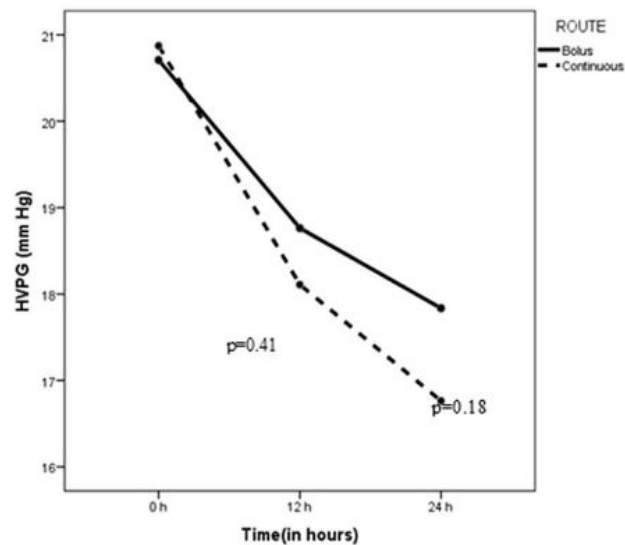
Hassan et al. Annals of Medicine & Surgery (2023)





Low-dose continuous terlipressin infusion is effective and safer than intravenous bolus injections in reducing portal pressure and control of acute variceal bleeding

Vinod Arora¹ · Shakti Prasad Choudhary¹ · Rakhi Maiwall¹ · Rajan Vijayaraghavan¹ · Ankur Jindal¹ · Guresh Kumar² ·



Terlipressin administration	HVPG0	HVPG12	HVPG24	p value
Bolus Terlipressin (n=55)	20.71 ± 3.73	18.76 ± 4.03	17.84 ± 4.20	< 0.001
Continuous Terlipressin Infusion (n=55)	20.87 ± 3.47	18.11 ± 4.22	16.76 ± 4.15	< 0.001
p value	0.81	0.41	0.18	

Ausência de falha terapêutica no grupo BIC
2 falhas terapêuticas com necessidade de TIPS de resgate no grupo BOL

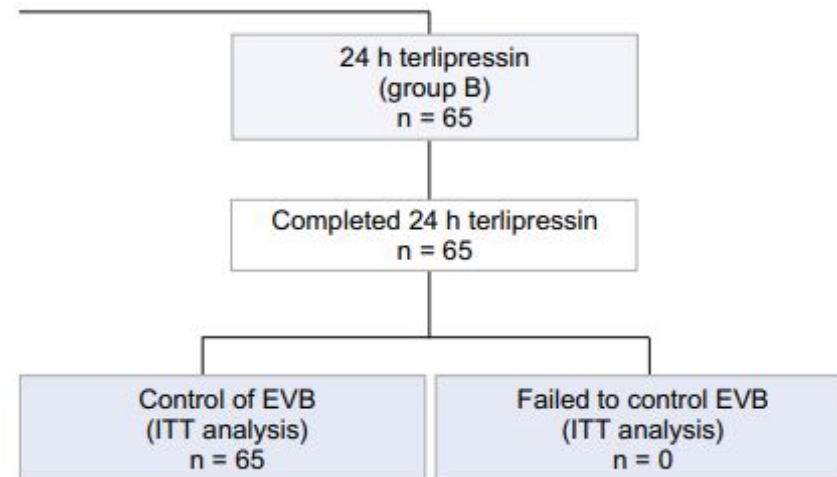
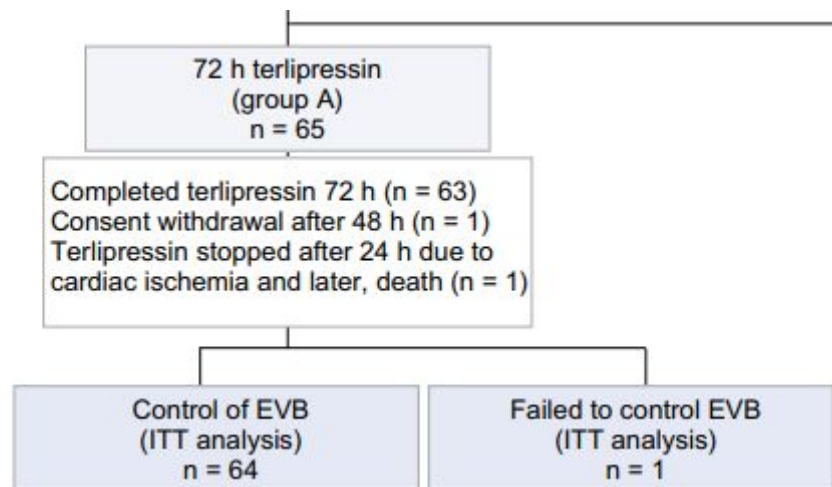
Hepatology International (2023) 17:131–138



Te1

Short course adjuvant terlipressin in acute variceal bleeding: A randomized double blind dummy controlled trial

Zahid Azam^{1,2}, Saeed Hamid^{1,*}, Wasim Jafri¹, Mohammad Salih¹, Zaigham Abbas¹,



Short course adjuvant terlipressin in acute variceal bleeding: A randomized double blind dummy controlled trial

Zahid Azam^{1,2}, Saeed Hamid^{1,*}, Wasim Jafri¹, Mohammad Salih¹, Zaigham Abbas¹,

Table 2. Secondary outcome measures.

	72 h terlipressin	24 h terlipressin	<i>p</i> value
30 days re-bleed			
(Mean days with 95% CI)	29.8 (29.5-30.1)	29.5 (28.8-30.2)	0.285*
No. with proportion	1 (1.5%)	2 (3.1%)	0.500†
30 days mortality			
(Mean days with 95% CI)	28.4 (27.1-29.7)	28.2 (26.8-29.6)	0.495*
No. with proportion	6 (9.2%)	6 (9.2%)	0.500†
Composite outcome (30 days failure to control EVB)			
(Mean days with 95 % CI)	28.4 (27.0-29.8)	28.2 (26.7-29.7)	0.495*
No. with proportion	7 (10.8%)	7 (10.8%)	0.500†



Delayed endoscopy increases re-bleeding and mortality in patients with hematemesis and active esophageal variceal bleeding: A cohort study

Ping-Hsien Chen^{1,6,†}, Wen-Chi Chen^{2,3,†}, Ming-Chih Hou^{1,2,6,*}, Tsu-Te Liu^{2,4}, Chen-Jung Chang^{1,2,7},

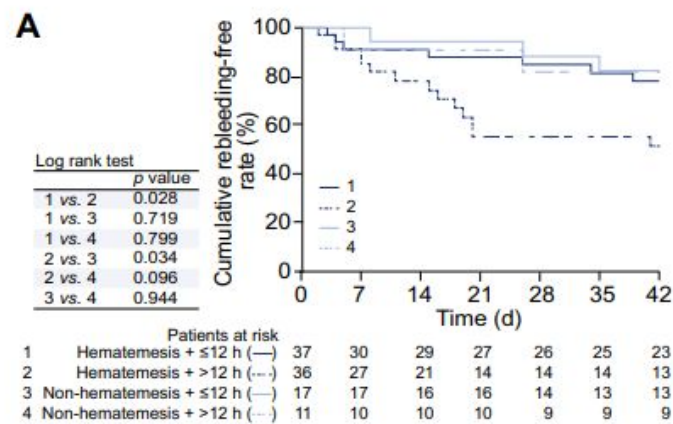
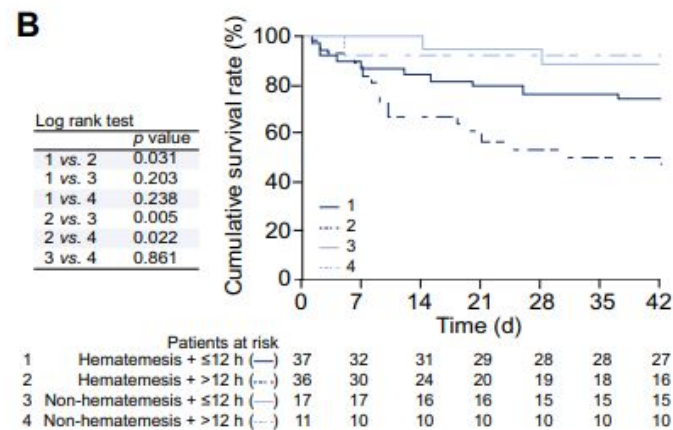


Table 3. Multivariate analysis of 6-week re-bleeding and mortality.

Predictor variables	HR	(95% CI)	p value
6-wk rebleeding			
Door-to-endoscopy (h)	1.015	(1.003-1.026)	0.015
MELD	1.098	(1.037-1.164)	0.001
Portal vein thrombosis	2.734	(1.228-6.088)	0.014
6-wk mortality			
Hematemesis at arrival	3.791	(1.145-12.55)	0.029
MELD	1.130	(1.081-1.180)	<0.001
HCC	3.518	(1.543-8.019)	0.003

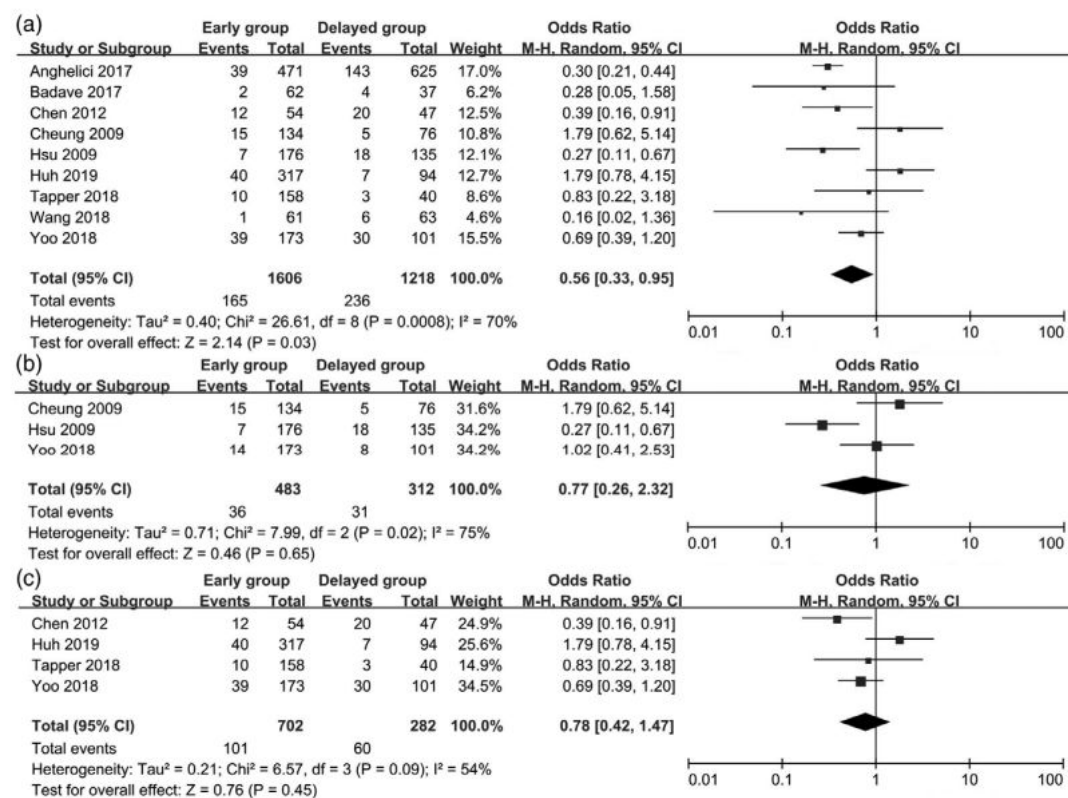


J Hepatol. 2012;57:1207–13.



Outcomes of early versus delayed endoscopy in cirrhotic patients with acute variceal bleeding: a systematic review with meta-analysis

Zhaohui Bai^{a,#}, Ran Wang^{a,#}, Gang Cheng^{a,#}, Dapeng Ma^{b,#}, Mostafa Ibrahim^c, Saurabh Chawla^d and Xingshun Qi^a



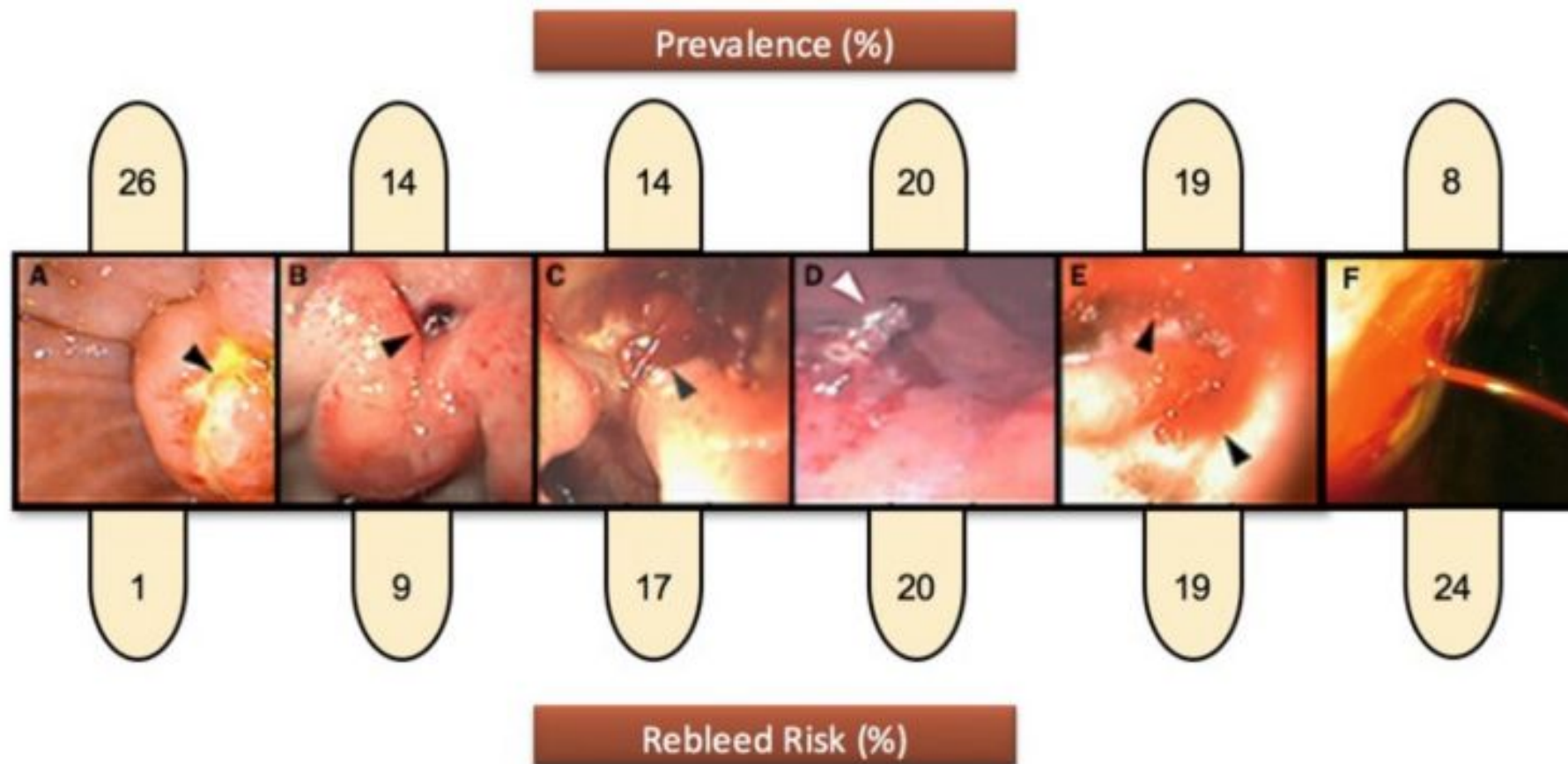
in 2 Meta-analyses comparing the mortality between early and delayed endoscopy groups: (a) Overall mortality; (b) in-hospital mortality; (c) 6-week



Classificação Endoscópica de Forrest

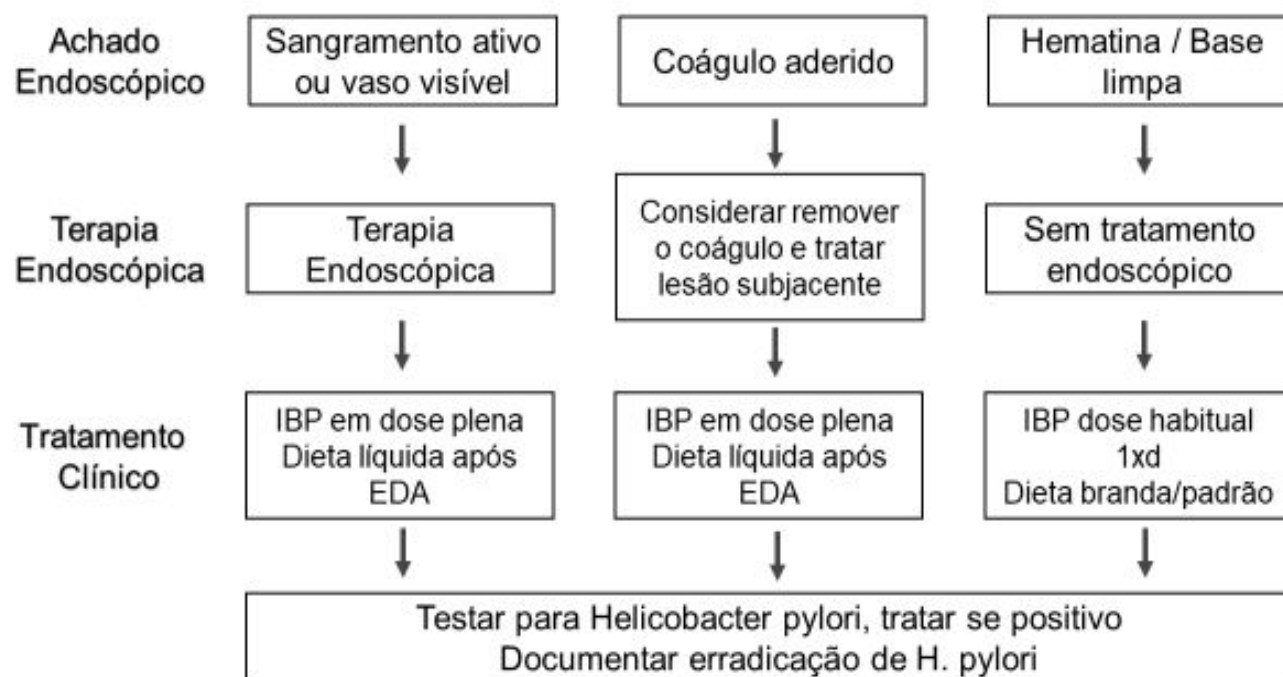
CLASSE DE FORREST	SANGRAMENTO (SG)	ACHADO ENDOSCÓPICO	RISCO DE RESSANGRAMENTO (%)
A	ATIVO	Vaso com SG em jato	100
I B	ATIVO	Vaso com SG em babação	17 - 100
II A	RECENTE	Vaso visível sem SG	8 - 81
II B	RECENTE	Úlcera com coágulo aderido	14 - 36
II C	RECENTE	Úlcera coberta por hematina ou mancha azul	0 - 13
III	AUSENTE	Úlcera com base limpa	0 - 10





J R Coll Physicians Edinb 2017; 47: 218–30

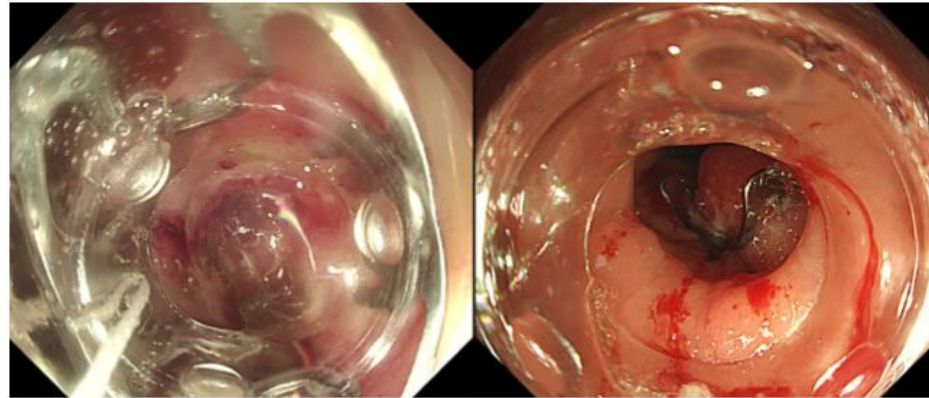
Tratamento endoscópico úlcera péptica



Am J Gastroenterol 2021;116:899–917



Terapia Endoscópica Combinada



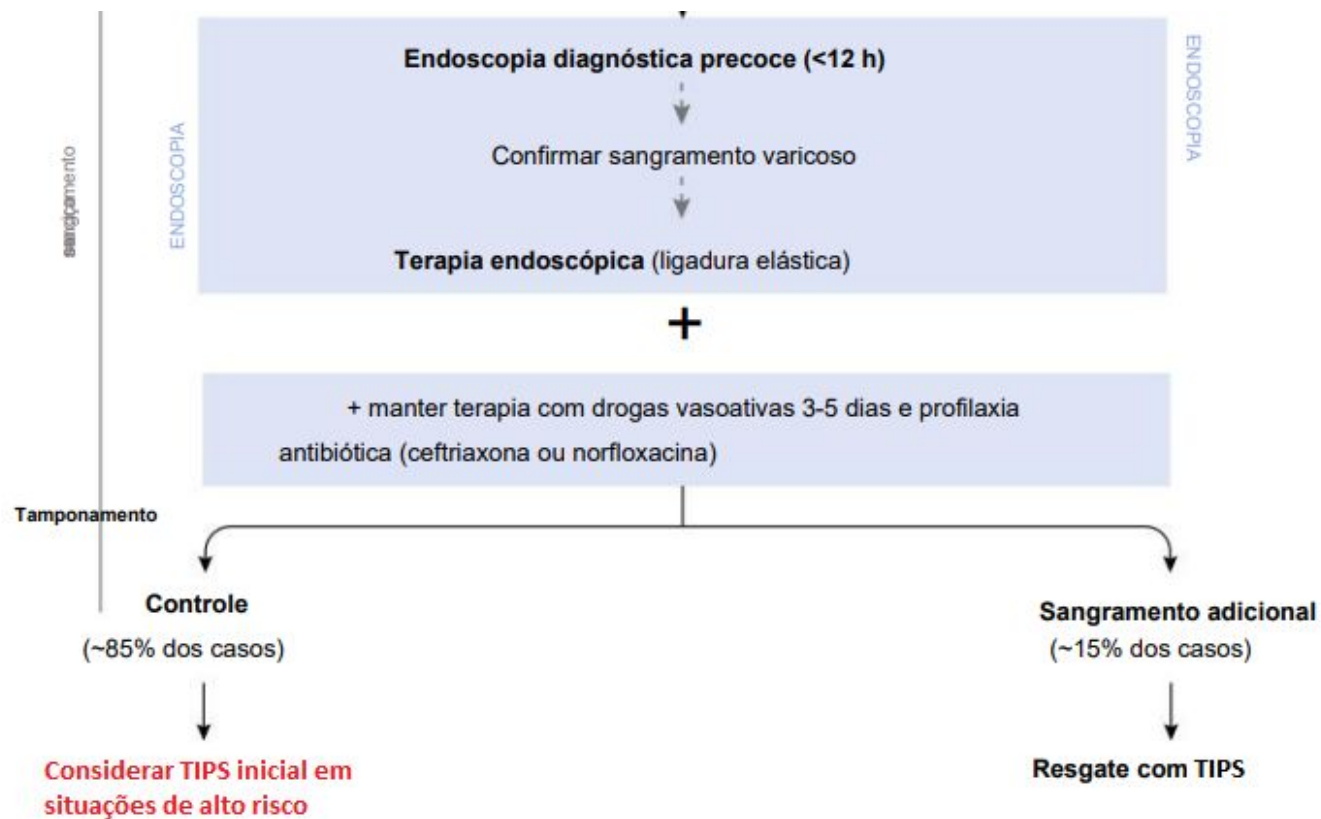
Digestive Endoscopy 2021;33:83–94



BMJMED 2022;1:e000202



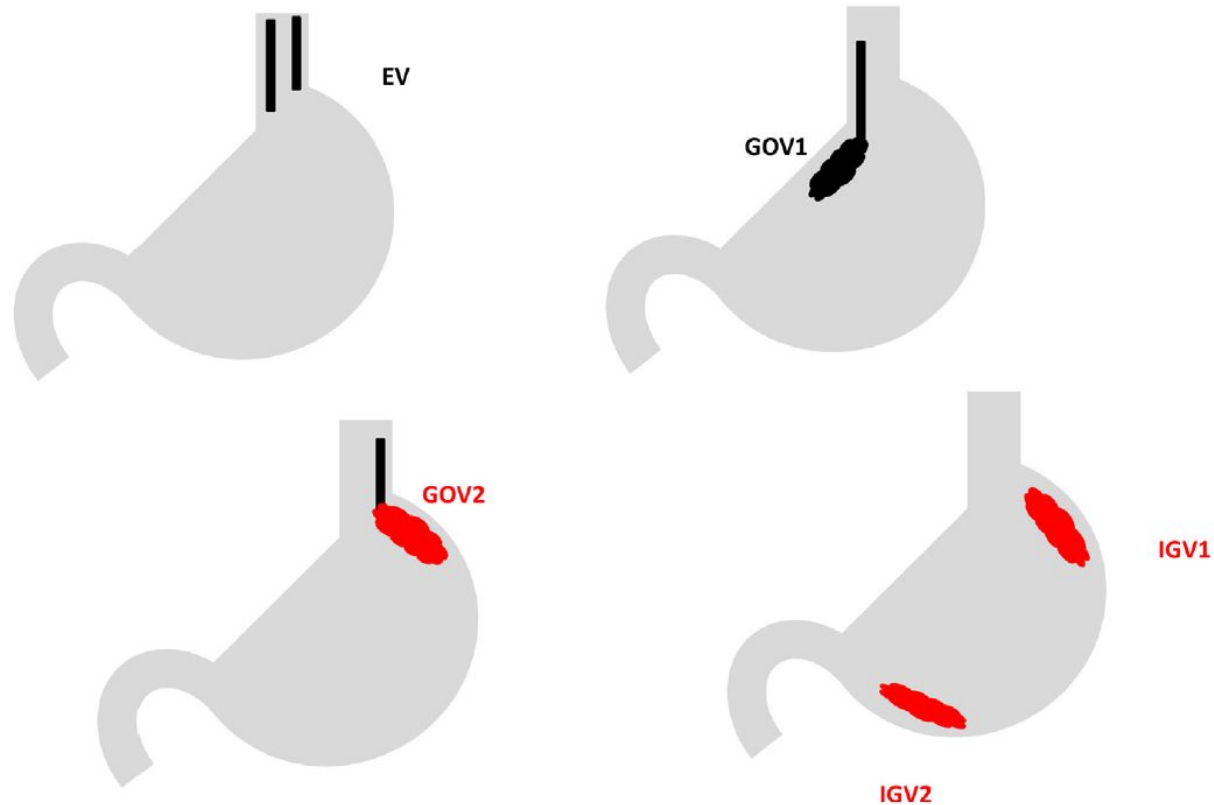
Manejo Invasivo HDA Varicosa



Decompensated Cirrhosis, EASL Guidelines 2018



Classificação de Sarin para Varizes Gástricas



Clin Liver Dis 24 (2020) 335–350.



Classificação de Sarin para Varizes Gástricas

Tipo	Definição	Relativo frequência	Sangramento geral risco sem tratamento
GOV 1	VGE estendendo-se abaixo da cárdia em menor curvatura	70%	28%
GOV 2	VGE estendendo-se abaixo da cárdia no fundo	21%	55%
IGV1	Varizes isoladas no fundo	7%	78%
IGV2	Varizes isoladas mais no estômago	2%	9%

EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol (2018)



Tratamento Endoscópico – Sangramento Varicoso

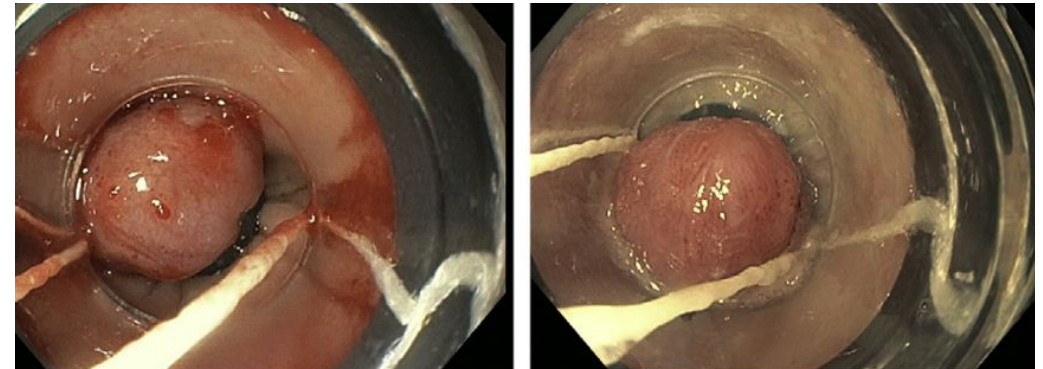
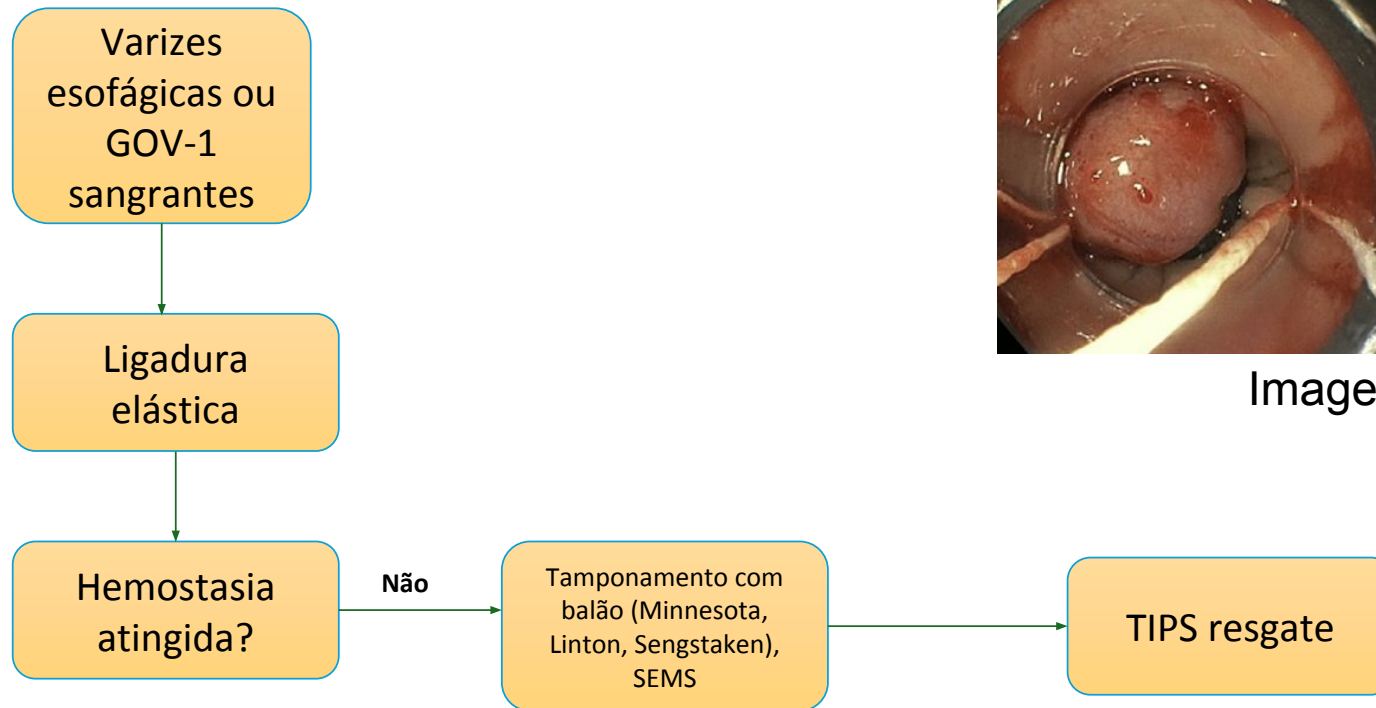


Imagem de Kovacs et al. 2019.

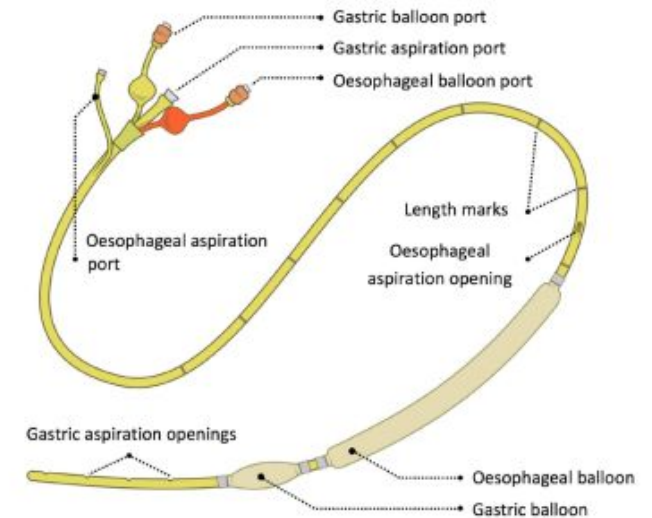
Hepatology. 2024;79:1180–1211



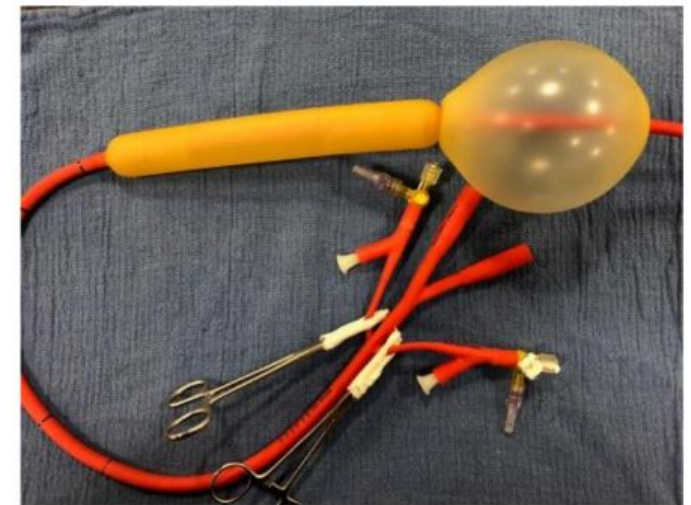
Medidas Temporárias de Hemostasia - BSB

- Controla sangramento em até 90% das HDAs varicosas
- Casos incontroláveis ou refratários a segunda endoscopia
- Pode ficar 24h, desinsuflar a cada 8 horas por 15 minutos
- Risco de úlcera isquêmica e até rotura
- Taxa de ressangramento 50-60% após ser desinsuflado
- Pensar em medidas de resgate enquanto isso
- Preferencialmente passado por via endoscópica
- Quando não for possível, aplicar anestesia tópica na narina, demarcar distância aproximada ao estômago e introduzir, insuflar aproximadamente 250 mL de ar para impactar na cardia, fixa com gaze e esparadrapo na narina, insufla balão esofágico em 25 mmHg

Rev. Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba, v. 10, n. 1, p. 5 - 10, 2008



J R Coll Physicians Edinb 2017; 47: 218–30



Balão de Sengstaken-Blakemore

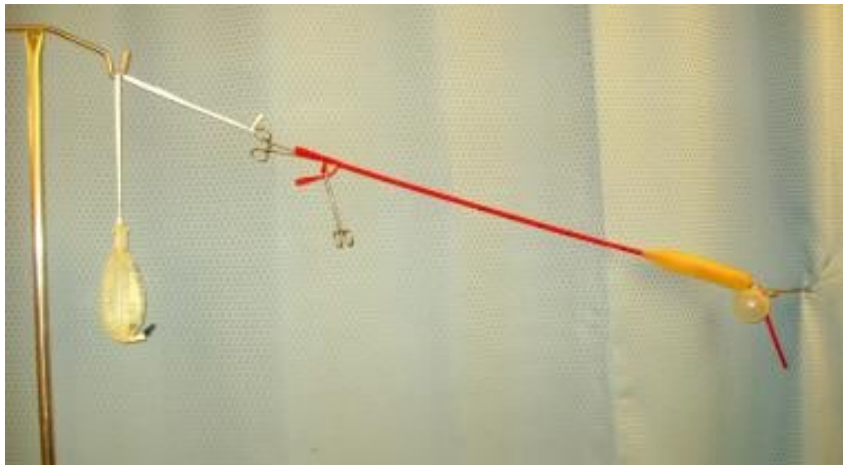
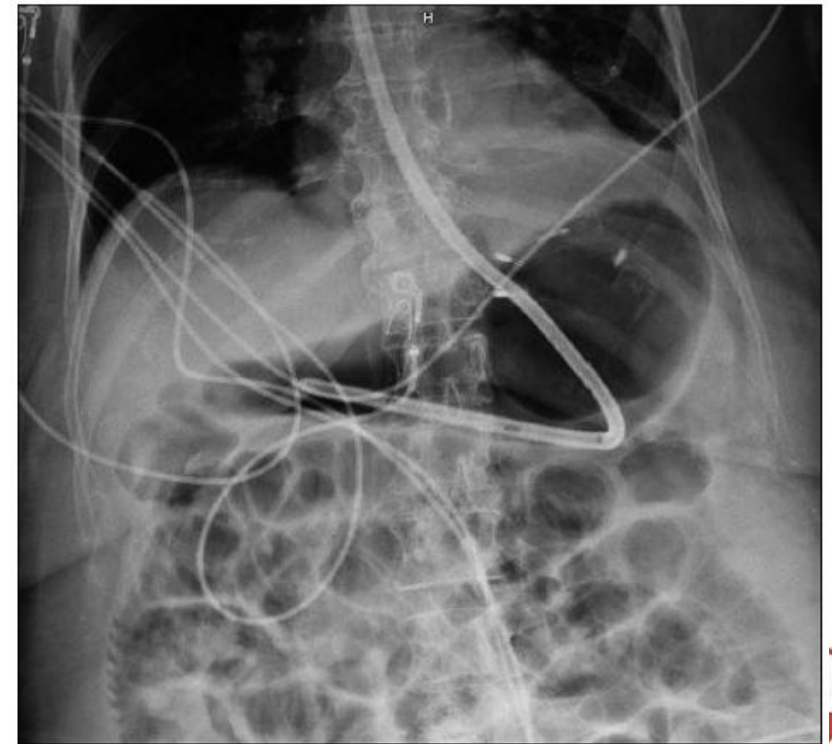


Imagem: emedicine.medscape.com

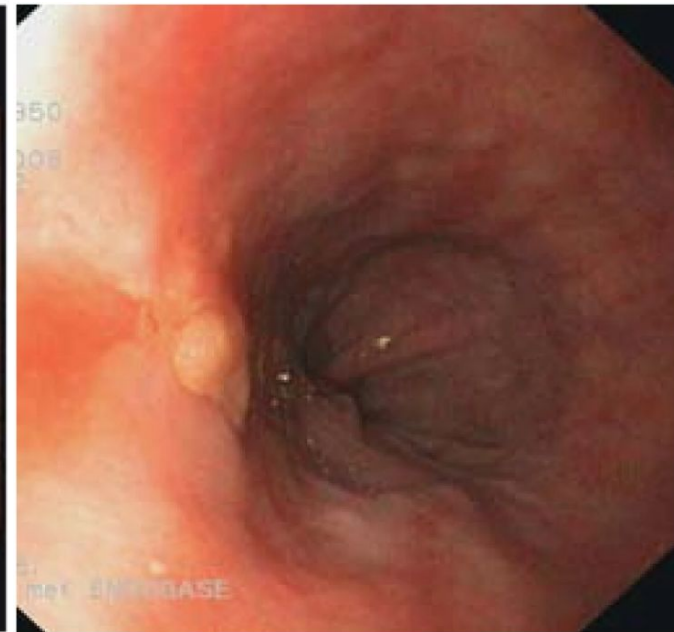
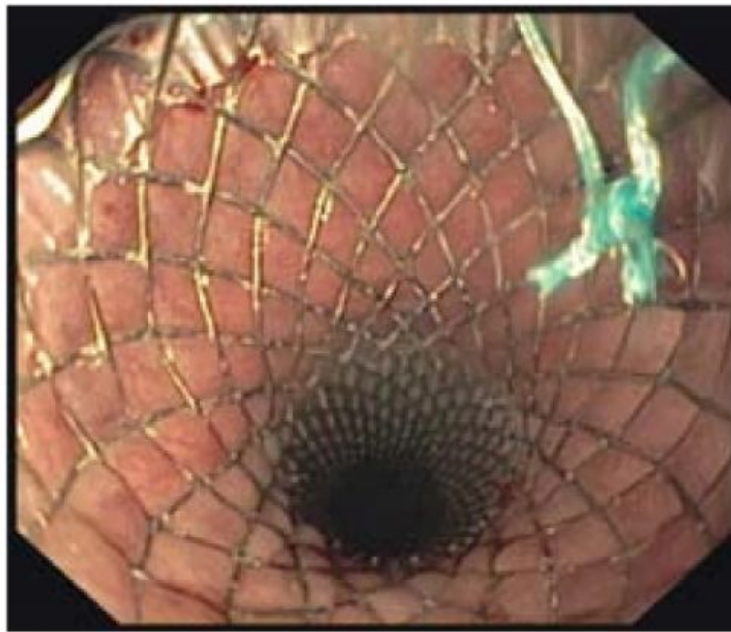


Balão de Sengstaken-Blakemore

ACG Case Reports Journal [6\(12\):p e00296, December 2019.](#) |



Medidas Temporárias de Hemostasia



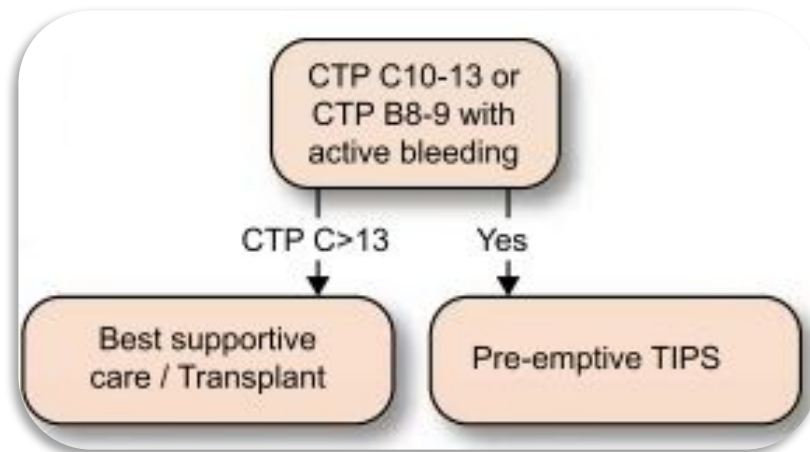
Fully covered self-expandable metal stents (SEMS), partially covered SEMS

van Boeckel et al. BMC Gastroenterology 2012, 12:19

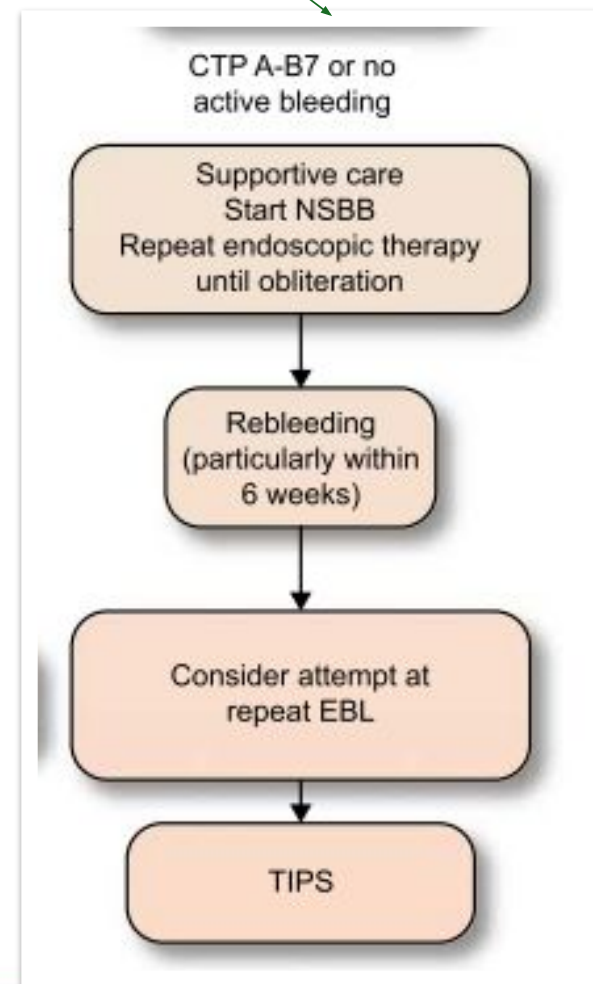


Hemostasia de VE ou GOV-1

Sim



Sim

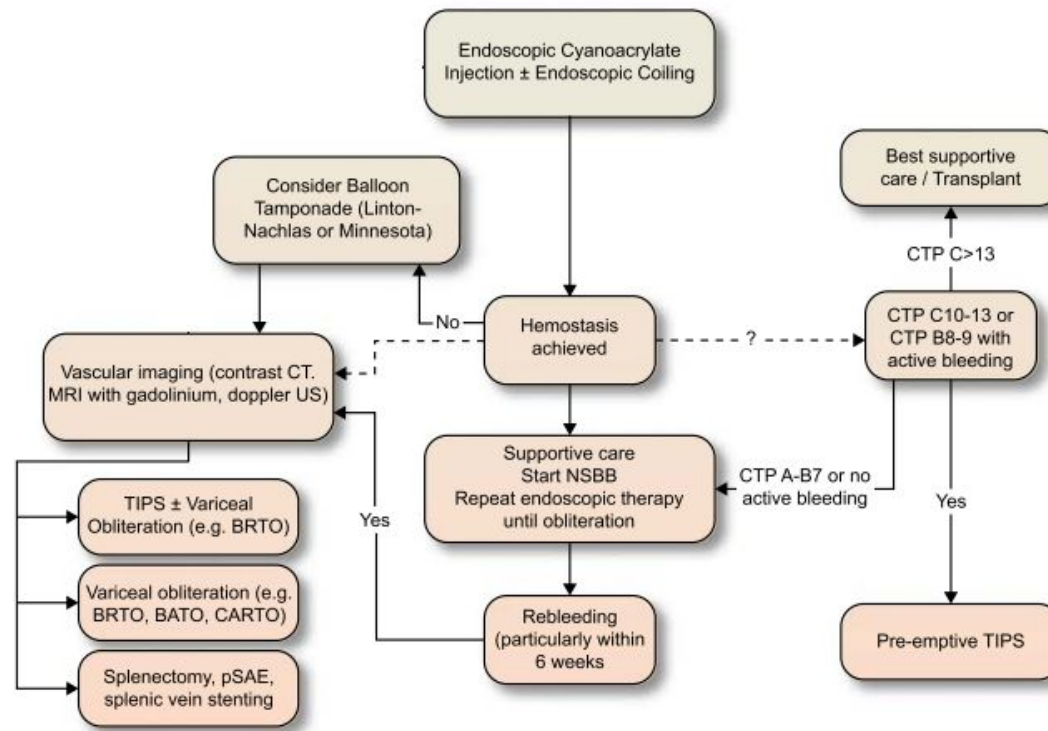


Hepatology. 2024;79:1180–1211



GOV-2 e IGV

Centro experiente em EDA +
Cianoacrilato

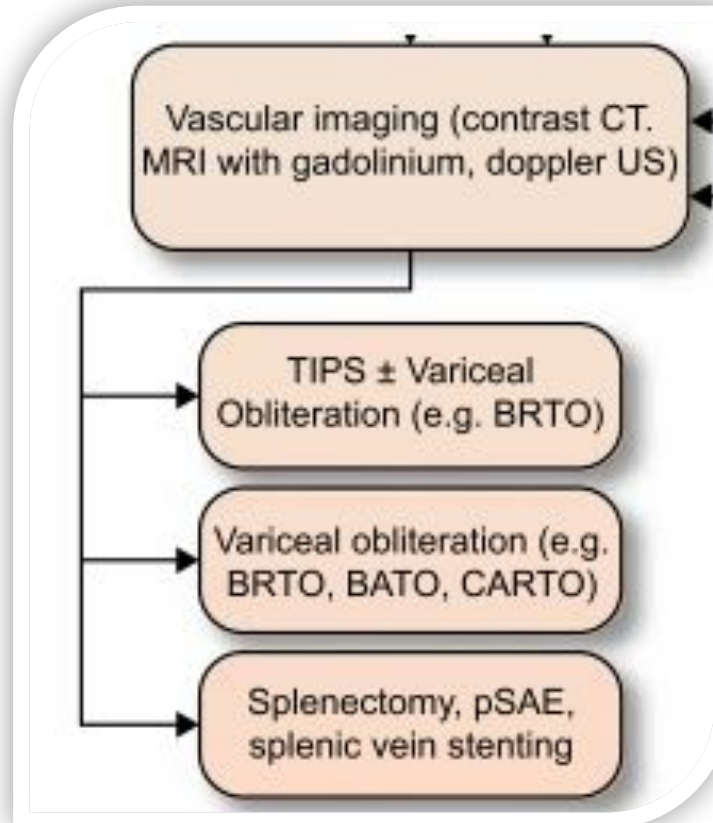


Hepatology. 2024;79:1180–1211



GOV-2 e IGV

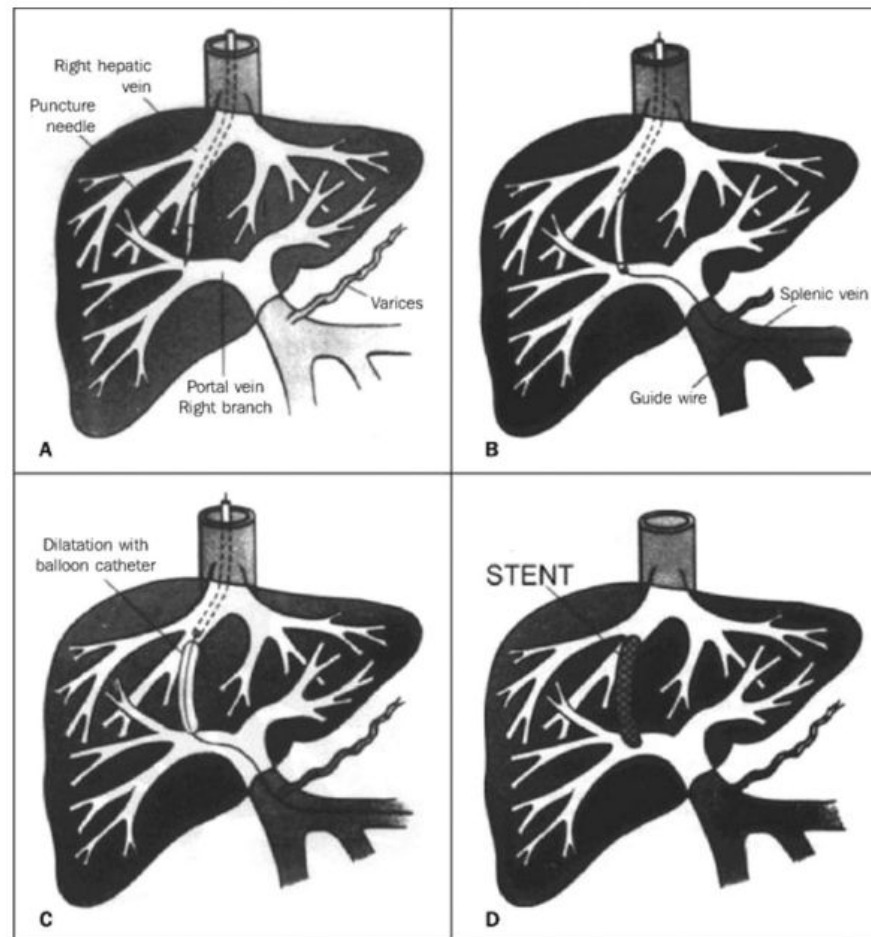
Ausência de experiência em EDA +
cianoacrilato



Hepatology. 2024;79:1180–1211



SHUNT PORTOSSISTEMICO TRANSJUGULAR



SHUNT PORTOSSISTÊMICO TRANSJUGULAR

TIPS PRECOCE

- Child-Pugh classe C <14 pontos ou Child-Pugh classe B >7 com sangramento ativo na endoscopia inicial ou HVPG >20 mmHg no momento da hemorragia
- Tratamento de varizes gástricas em locais onde cianoacrilato não é disponível
- Tratamento inicial para varizes ectópicas

TIPS DE RESGATE

- Ressangramento após controle inicial de sangramento e falha na 2a endoscopia

- Pacientes com Child-Pugh >14 , ou com pontuação MELD >30 e lactato >12 mmol/L → mais indicada referência a TH!



CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

CONTRAINDICAÇÕES AO TIPS

ABSOLUTAS

- Insuficiência cardíaca,
- hipertensão pulmonar grave,
- Infecção sistêmica não controlada ou sepse,
- Regurgitação tricúspide grave

RELATIVAS

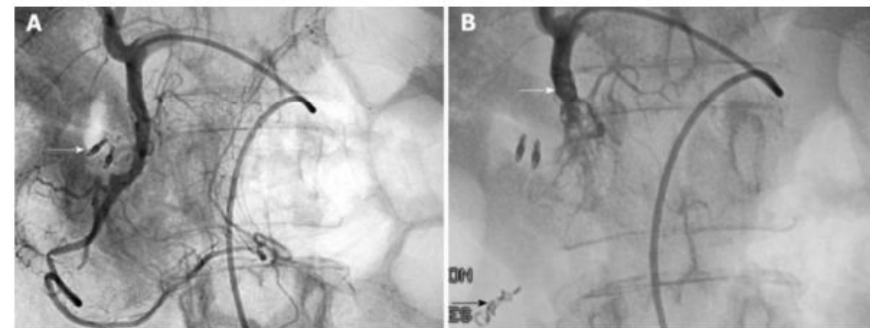
- Carcinoma hepatocelular (particularmente se central),
- Trombose da veia porta
- Coagulopatia ou trombocitopenia grave

TRATAMENTO CIRÚRGICO?

EFICAZ NO CONTROLE DE MORTALIDADE ATÉ 50%

Shunt Cirúrgico
Transecção esofágica com ligadura manual
Desvascularização JEG

ARTERIOGRAFIA?



FLUXOGRAMA DE MANEJO HDA

	CHECKLIST BÁSICO	NÃO FAZER
Sangramento alto TGI em cirrótico ○ ABCD, transfusão restritiva ○ Emprego de drogas vasoativas ○ Antibioticoterapia ○ Endoscopia Digestiva alta	• Ressuscitação em ambiente controlado com monitorização • Transfusão para Hb 7-8 g/dL • Drogas vasoativas (p. ex. octreotide) • Paracentese diagnóstica • Antibiótico profilático (Ceftriaxona)	<u>Precocemente</u> - Hiper / hiporessuscitação - Uso excessivo de CH, PFC, unidades de plaquetas - Atrasar início de drogas vasoativas - Atrasar ou esquecer de antibiótico - Atraso EDA/ligadura - Falha em identificar grupo com benefício para TIPS precoce <u>Alta Hospitalar</u> - Manutenção de antibióticos e IBP - Não introdução de betabloqueadores e não agendamento de EDA/ligadura
Sangramento varicoso confirmado ○ Ligadura endoscópica ○ Injeção de cola / BRTO (varizes de fundo) ○ TIPS preemptivo em alto risco	• Tratamento endoscópico ou por radiointervenção de varizes • USG / Doppler hepático • Calcular Child-Pugh e MELD • Classificação de risco para ressangramento/óbito (Child-Pugh 10-13 = considerar TIPS preemptivo) • Sangramento refratário -> medidas temporárias até TIPS de resgate	
Sangramento varicoso refratário ○ Medidas temporárias ○ TIPS de resgate		
Profilaxia secundária do sangramento varicoso - Betabloqueadores não seletivos - Repetir ligadura endoscópica	- Betabloqueadores não seletivos e ligadura, a não ser que TIPS - Iniciar betabloqueadores ANTES da alta hospitalar se ausência de contraindicações ou de TIPS - Agendar endoscopia para nova ligadura, a não ser que TIPS	

Jakab, SS and Guadalupe Garcia-Tsao et al. Evaluation and Management of Esophageal and Gastric Varices in Patients with Cirrhosis. Clin Liver Dis 24 (2020) 335–350.



Obrigado!

Dúvidas?

Encaminhar para
gastrointensiva@gmail.com

